Centre hospitalier de Valmont
Pôle cardio-vasculaire — Service de cardiologie
14, avenue des Tilleuls — 45390 Valmont-sur-Loire
Secrétariat : 01 99 00 41 17

Compte rendu d'hospitalisation

Patiente	Mme MARCHETTI Hélène
Née le	03/06/1951 (75 ans)
N° de séjour	2026-104471
Entrée	06/10/2026, par les urgences
Sortie	13/10/2026, retour à domicile
Médecin traitant	Dr Paul Ricaud, Valmont-sur-Loire

Cher Confrère,

Nous avons pris en charge votre patiente, Mme Marchetti, du 6 au 13 octobre 2026 pour une décompensation cardiaque globale. Vous trouverez ci-dessous la synthèse de son séjour.

Motif d'hospitalisation

Dyspnée d'effort d'aggravation progressive depuis dix jours, associée à des œdèmes des membres inférieurs et à une orthopnée à deux oreillers.

Antécédents

- Hypertension artérielle traitée depuis 2009
- Fibrillation atriale paroxystique diagnostiquée en 2021, sous anticoagulant
- Diabète de type 2 non insulinorequérant
- Cholécystectomie en 1998

Veuve, elle vit seule au premier étage sans ascenseur et reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Pas de tabagisme, pas de consommation d'alcool.

Histoire de la maladie

La patiente rapporte une prise de poids d'environ quatre kilogrammes en deux semaines, survenue après un épisode de bronchite traité par son médecin traitant. Elle a été adressée aux urgences par SOS Médecins devant une saturation à 89 % en air ambiant. À l'arrivée, l'électrocardiogramme montrait une fibrillation atriale rapide à 118 battements par minute.

Examen clinique à l'entrée

Poids 71,4 kg pour 1,62 m, pression artérielle 158/92 mmHg, fréquence cardiaque 112 par minute irrégulière, SpO2 91 % en air ambiant. On note des crépitants aux deux bases pulmonaires, une turgescence jugulaire et des œdèmes prenant le godet jusqu'aux genoux.

Examens complémentaires

Biologie

Tableau 1 — Évolution des principaux paramètres biologiques

Paramètre	Résultats			Valeurs usuelles
	Entrée	J3	Sortie	
Hémoglobine (g/dL)	12,1	11,8	12,0	12,0 – 16,0
Sodium (mmol/L)	133	136	138	136 – 145

Paramètre	Résultats			Valeurs usuelles
	Entrée	J3	Sortie	
Potassium (mmol/L)	4,8	4,1	4,3	3,5 – 5,0
Créatinine (µmol/L)	118	126	109	45 – 90
NT-proBNP (pg/mL)	6 840	—	2 115	< 450
Troponine T hs (ng/L)	21	19	—	< 14
HbA1c (%)	7,4	—	—	< 6,5

Imagerie et électrocardiogramme

La radiographie thoracique montre une cardiomégalie avec un épanchement pleural bilatéral de faible abondance. L'échocardiographie transthoracique retrouve une fraction d'éjection ventriculaire gauche estimée à 38 %, sans valvulopathie significative. Les pressions de remplissage sont élevées.

Évolution

Sous diurétiques intraveineux, l'évolution a été favorable avec une perte de poids de 4,2 kg en six jours. La fréquence cardiaque a été contrôlée par l'introduction d'un bêtabloquant à dose progressive. La fonction rénale est restée stable, avec une créatinine de sortie à 109 µmol/L. La patiente a bénéficié d'une séance d'éducation thérapeutique sur la surveillance du poids et le régime pauvre en sel.

Traitement de sortie

Médicament	Posologie	Remarque
Furosémide 40 mg	1 comprimé le matin	Adapter selon le poids
Bisoprolol 2,5 mg	1 comprimé le matin	Augmentation prévue en consultation
Ramipril 2,5 mg	1 comprimé le soir	Nouveau traitement
Apixaban 5 mg	1 comprimé matin et soir	Inchangé
Metformine 1000 mg	1 comprimé matin et soir	Inchangé

Suivi proposé

- Pesée quotidienne ; consulter si prise de plus de 2 kg en trois jours
- Bilan sanguin (ionogramme, créatinine) dans une semaine
- Consultation de cardiologie le 17 novembre 2026 à 10 h 30
- Réadaptation cardiaque à discuter lors de cette consultation

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, cher Confrère, à l'assurance de mes sentiments confraternels.

Dr Claire Vasseur-Diallo
Praticien hospitalier, cardiologie

Copie : patiente ; Dr Paul Ricaud, médecin traitant.